X FOVO.

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Fabián Ignacio Montoya Pérez				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	28/07/2015	Edad actual	10 años	07 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Rafael Elqueta H. 1802 los Andes				Teléfono	962561242	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende X	habla X	lee X	escribe X	
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende X	habla X	lee X	escribe X	
Escolaridad actual:	5° bás.	Establecimiento					

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 11/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Jery Pérez	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Mamá.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 11/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Enicka Caldeira	Nombre:
Rol/cargo: Psicopedagoga.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Requiere apoyo de fonoaudiología, ya que su dificultad es en lenguaje, lo cual repercute en sus aprendizajes a nivel de lectura y escritura.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☐ Si (especificar)

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: TEL	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: [X] normal [ ] inducido [X] fórceps [ ] cesárea (señalar motivo) muy grande.

Tuvo asistencia médica durante el parto? [X] SI [ ] NO | Peso: 4.030 kg. | Talla: 53 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

sin antecedentes relevantes.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	~~Sí~~	No	Enfermedad respiratoria	~~Sí~~	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	~~Sí~~	No	Especifique motivos y duración: neumonia 2 meses antes del año y hospitalizacion 1 mes cada uno.					

Se realizaron controles periódicos de salud [~~Sí~~] [No] | Vacunas [~~Sí~~] [No]

Observaciones:

sin observaciones.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza:	—	Se sienta sólo/a:	—	Camina sin apoyo:	antes de 12 m.
Primeras palabras:	—	Primeras frases:	—	Se viste solo/a:	—

Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Observaciones: Desarrollo previo, sin embargo, a los 12 meses retrocedio, por una perdida con padre biológico en quien no tenia cercania. (Atipico X)

En su actividad motora general se aprecia: [X] normal [ ] activo [ ] hiperactivo [ ] hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia: [X] normal [ ] hipertónico [ ] hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones:

Adecuado desarrollo segun lo informado por la madre.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí X	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí X	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí X	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí X	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí X	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí X	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí X	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No X
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí X	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No X
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí X	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No X
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No X	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No X
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí X	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No X

Observaciones: Asmatica, miopía y astigmatismo, usuaria de lentes, con controles periódicos.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí X	No	Emite/produce frases	Sí X	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí X	No	Relata experiencias	Sí X	No
Emite palabras/produce señas	Sí X	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No X

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Sí X	No	Sigue instrucciones simples	Sí X	No
Identifica personas	Sí X	No	Sigue instrucciones complejas	Sí X	No
Comprende conceptos abstractos	Sí X	No	Sigue instrucciones grupales	Sí X	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí X	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí X	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): Sí, según madre a los 12 m. por cuadro asociado con padre biológico.

Observaciones:

Relata experiencias, pero se le entiende poco.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí X	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí X	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí X	No	Respeta normas sociales	Sí X	No
Participa en actividades grupales	Sí X	No	Respeta normas escolares	Sí X	No
Opta por trabajo individual	Sí	No X	Muestra sentido del humor	Sí X	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No X	Movimientos estereotipados	Sí	No X
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No X	Pataletas frecuentes	Sí	No X

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	Sonidos:	Personas extrañas:
X natural ☐ desmesurada	X natural ☐ desmesurada	X natural ☐ desmesurada

Observaciones:

Sin dificultades.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Usual 1 vez al año. respiratorio cada 4 meses.

Alimentación: X normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): X normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: X normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 8 - 9 app.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo X despierta de buen humor

Duerme: X solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

X alegre ☐ juguetón/bromista X risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones:

sin observaciones.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Tery Pérez	mamá	28	Sup.	Tec. en enfermería
2. Astrid Robles	Hermana	8a	3°	Estudiante
3. Ariel Robles	Papá (padrastro)	31	Sup.	Capataz Eléctrica.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

generalmente el apoyo es de su mamá. no existen mayores antecedentes familiares relevantes.

Observaciones:

sin observaciones.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	3a	Asistió a jardín infantil	Sí X	No
Nº de colegios en que ha estudiado	3	Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☒ Técnica ☐:		
Motivo de los cambios: Por movilización. Llega a 2º básico al establecimiento				
Ha repetido curso/s	Sí	No X	Curso(s) —	Motivo: —

Situación actual

Nivel/curso actual	5º C		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No X	**Dificultad para participar**	Sí	No X	**Conducta disruptiva**	Sí	No X
Asiste regularmente	Sí X	No	Asiste con agrado	Sí X	No	Apoyo familiar en tareas	Sí X	No	Amigos (as)	Sí X	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
X satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
X apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
X apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
X expresiones afectivas X alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
X madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
X alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☐ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) X Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Padre ausente desde el embarazo, actualmente se ven 2 veces al año.
Desde los 4 meses figura paterna la triple pareja de la mamá hasta la actualidad.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY